Onde o grupo *perde dinheiro*

Ficha de diagnóstico consolidado, versão rede e grandes hospitais. Aplicada antes de qualquer plano.

Como usar. Esta ficha não se preenche com o dono sozinho. A mesa tem que ter sócios, diretoria e quem responde pelo financeiro. Parte das respostas vem de documento, não de memória, e é melhor deixar em branco do que estimar.

O que esta ficha tem a mais que a do hospital dia. Mapa de unidades, consolidação, dívida separada por urgência e governança. Em grupo com várias unidades, o problema quase nunca está dentro de uma unidade: está no que ninguém consolida.

Sigilo. Tudo o que está escrito aqui é confidencial entre o grupo e a Sena e Bittar, e não sai desta sala sem autorização.

O grupo

NOME DO GRUPO

HOLDING, SE HOUVER (CNPJ)

UNIDADES EM OPERAÇÃO

CNPJS ATIVOS

TEMPO DE GRUPO

SÓCIOS E PARTICIPAÇÃO

QUEM RESPONDE PELA DIRETORIA

QUEM RESPONDE PELO FINANCEIRO

FATURAMENTO CONSOLIDADO MÉDIO MENSAL

COLABORADORES CLT

PJS

DATA DO DIAGNÓSTICO

QUEM PARTICIPOU DESTA REUNIÃO

BLOCO 01

MAPA DE UNIDADES

A unidade que fatura tapa o buraco da que não performa.

O SISTEMA MEDE · Resultado de cada unidade, isolado do consolidado

Uma linha por unidade. Se o resultado isolado de alguma não existir hoje, escrever "não apurado". Essa resposta vale mais que um número chutado.

UNIDADE	CIDADE	CNPJ	FATURAMENTO MÉDIO	RESULTADO	PESSOAS	DESDE

01 **Alguma unidade é hoje sustentada por outra? Qual, há quanto tempo, e quem sabe disso?**

02 **Qual foi a última unidade aberta, e ela teve estudo de viabilidade antes? Quem assinou?**

BLOCO 02

GOVERNANÇA

Sem mesa com mandato, a operação só apaga incêndio.

03 **Quem decide investimento acima de que valor, e isso está escrito em algum lugar?**

04 **Existe mesa de diretoria que se reúne com pauta e ata, ou as decisões acontecem no corredor?**

05 **Nos últimos 24 meses, quantas pessoas ocuparam a direção financeira? Por que cada uma saiu?**

Alguma delas concluiu um diagnóstico, ou cada entrante recomeçou do zero?

06 **Quem hoje tem acesso direto à informação fiscal na fonte, e não por relato de terceiro?**

07 **Existe gestor por unidade com meta e autonomia, ou tudo sobe para a diretoria?**

BLOCO 03

CONSOLIDAÇÃO E CENTRO DE CUSTO

O que não é separado por unidade não é diagnóstico, é média.

O SISTEMA MEDE · Dia do mês em que o consolidado fica pronto

08 **Existe centro de custo separado por unidade, ou o resultado só aparece consolidado?**

09 **Até que dia do mês o consolidado fica pronto, e quem lê antes de o mês seguinte começar?**

10 **As unidades usam o mesmo plano de contas e o mesmo sistema?**

11 **Existe rateio ou cobrança entre as unidades e a holding? Com que critério, e desde quando?**

BLOCO 04

DÍVIDA E CAIXA

Dívida se separa por urgência de risco, não por tamanho.

12 **Folha e encargos estão em dia? Se não, de quando é o atraso e de quais unidades?**

13 **Fornecedor estratégico, aquele que para a operação se parar de entregar: está em dia?**

14 **Aluguel e ocupação estão em dia? Existe ação judicial em curso?**

15 **Diretoria, comissões e repasses de médicos estão em dia?**

16 **Qual foi o último aporte ou empréstimo, e para onde o dinheiro foi de fato?**

Dívida operacional, expansão ou despesa corrente?

17 **Existe capital de giro separado do caixa da operação?**

BLOCO 05

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E TRIBUTÁRIA

Vários CNPJs, várias decisões. Quase sempre tomadas em anos diferentes.

18 **Cada CNPJ está em que regime, e quem decidiu por cada um?**

19 **A holding, se existir, recebe o quê e a que título?**

20 **As unidades emitem nota com a mesma descrição e o mesmo código de serviço?**

A redução de 60% de IBS e CBS depende da classificação correta na NBS. Código errado perde o redutor, mesmo sendo saúde de fato.

21 **Existe passivo tributário? Parcelamento em curso? Em quais CNPJs?**

BLOCO 06

PADRÃO E REPLICABILIDADE

O que é política do grupo, e o que é combinado unidade a unidade?

22 **Quais rotinas críticas têm POP escrito, e quando foi a última revisão?**

23 **Se uma unidade nova abrir em 90 dias, existe manual para operá-la?**

24 **Quantos médicos no grupo, com que vínculo, e o critério de repasse está escrito?**

25 **Qual foi a rotatividade da gerência das unidades nos últimos 12 meses?**

BLOCO 07

SINAIS DE ALERTA

Marcados pelos mentores durante a conversa, não perguntados em voz alta.

- ☐ Troca de direção financeira em sequência, sem que ninguém tenha concluído um diagnóstico.
- ☐ Terceiros circulando ao redor do dono oferecendo solução mágica.
- ☐ Nenhuma mesa de decisão com mandato para dizer não a uma decisão ruim.
- ☐ Centro de custo não separado por unidade.
- ☐ Gasto de vaidade convivendo com atraso de folha, aluguel ou fornecedor.
- ☐ Aporte ou empréstimo usado em despesa corrente em vez de dívida operacional.
- ☐ Ferramenta ou consultoria contratada sem conferir se aquela unidade sustenta mais um custo fixo.
- ☐ Expansão anunciada com o básico ainda não saneado.
- ☐ Corte de custo feito em cima do que sustenta a operação.

Três ou mais marcados mudam a natureza do trabalho. O que entra ali é turnaround, com entrada própria, e as condições abaixo deixam de ser recomendação.

BLOCO 08

CONDIÇÕES DE ENTRADA

Sem as duas, o trabalho não começa.

1. Acesso à informação na fonte.

Procuração digital para o SB ver a informação fiscal e tributária direto, sem depender do relato de quem está no comando. Cada pessoa conta a história do seu jeito, e diagnóstico feito sobre relato não se sustenta.

☐ Concedido ☐ Em processo ☐ Negado

2. Mandato formal.

Compromisso escrito de que quem manda não atravessa a execução durante o período combinado. Não se arruma a casa com alguém desfazendo atrás.

☐ Assinado ☐ Em negociação ☐ Negado

FECHO DO ENCONTRO

LINHA DE PARTIDA CONSOLIDADA

É contra estes números que os 90 dias vão ser medidos.

INDICADOR	HOJE	COMO FOI APURADO
Faturamento consolidado soma das unidades, sem duplicar rateio		
Resultado consolidado depois de imposto, antes de distribuição		
Unidades no vermelho quantas, e há quantos meses		
Dívida total separada por categoria de urgência		
Margem líquida consolidada resultado dividido pela receita		
Centro de custo por unidade existe, sim ou não		

Se algum destes não puder ser apurado hoje, escrever "não apurado" em vez de estimar. Saber que não se sabe já é diagnóstico, e em grupo multiunidade é o diagnóstico mais comum.

O que o grupo entrega até o próximo encontro

- Balancete consolidado e por unidade, últimos 12 meses
- Extratos bancários dos últimos 6 meses, por CNPJ
- Relação de dívida por credor e por vencimento, separada por categoria
- Contrato social de cada CNPJ e da holding
- Guias de imposto dos últimos 12 meses, por CNPJ
- Folha de pagamento e relação de PJs, por unidade
- Contratos do corpo clínico e o critério de repasse
- Contratos de aluguel das unidades
- Último estudo de viabilidade feito, de qualquer unidade
- Atas de reunião de diretoria dos últimos 12 meses, se existirem
- Amostra de notas fiscais de cada unidade, para ver como o serviço está descrito

As três decisões do trimestre

Três. Não dez. Escritas aqui, na frente da mesa, antes de todo mundo levantar.

DECISÃO 1

DECISÃO 2

DECISÃO 3

ASSINATURA PELO GRUPO

PELA SENA E BITTAR

“Dinheiro não é pó, é semente.”

SENA · BITTAR